

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	思覺失調症 Schizophrenia				
編號	A31000-Q03-W-L02	制定者	PSY 李家靜	公布日期	102 年 02 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.2 版/12 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解思覺失調症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

思覺失調症是一種思考、情緒、知覺、行為障礙的疾病，會有不合於現實的想法、意念或認知而嚴重影響生活功能。因腦內神經傳導物質「多巴胺」失調所引起的一種嚴重的慢性腦功能障礙疾病，發病年齡多在 15~45 歲（青年及成年早期），有妄想與幻聽的臨床表徵，儘管規則的接受藥物治療，仍存有部分殘餘症狀，且反覆發作，其病程偏向慢性化和認知退化，需要長期服藥及復健治療。

（二）診斷

思覺失調症的症狀若持續 6 個月以上即可確立診斷，若超過 2 年則屬慢性思覺失調症。根據美國精神醫學會精神疾病診斷準則手冊第五版 DSM-5(2014)的診斷標準如下：

1. 標準 A：在 1 個月期間（或是如果成功治療時病程少於 1 個月），出現以下症狀至少兩項，包括(1)妄想、(2)幻覺、(3)混亂的言語、(4)混亂或僵直行為、(5)負面症狀；其中至少有一項必須為妄想、幻覺或混亂的言語。

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	2/12

2. 標準 B：發病以來的大部分時間，有一項或多項主要領域功能比未發病前顯著降低（例如工作、人際關係或自我照顧）；或當孩童或是青少年發作時，無法達到預期的人際關係、學業或職業功能。
3. 標準 C：符合標準 A，有正性症狀的時間必須持續一個月以上，且有症狀的時間，包括前驅期、急性發病期及殘餘期的總時間必須超過六個月以上。
4. 標準 D：必須排除情感性精神病及情感性思覺失調症。
5. 標準 E：必須排除一般醫學狀況或物質使用誘發之精神病。
6. 標準 F：若有自閉症或其他廣泛性發展疾患的病史，需有明顯的妄想或幻覺至少存在一個月（或是成功治療後略少於一個月）。

（三）分類

過去美國精神醫學會精神疾病診斷準則手冊第四版(DSM-IV-TR)將此疾患分為五種亞型—妄想型、青春型、僵直型、單純型、未定型。此分類方式在美國精神醫學會精神疾病診斷準則手冊第五版 DSM -5(2014)的診斷標準中已取消所有亞型，但有鑑於此分類方式於思覺失調症症狀學中仍多有參考價值，故仍列以下亞型以供參考。

1. 妄想型(paranoid type)：發病年齡多在中年期，病初敏感多疑，逐步發展成妄想。一般多表現為被害妄想，其他如嫉妒、物理影響、疑病或軀體改變等妄想。常伴有幻覺和怪異行為，情感反應與妄想內容往往不協調。病程進展較為緩慢，精神衰退常不甚明顯。
2. 青春型(hebephrenic type)：發病多在 15～25 歲，此型以情感改變和聯想障礙表現為主，常伴以自笑，且變化莫測；思維凌亂、語句含混或呈破裂型思維；行為怪異、愚蠢、作態較為常見。妄想和幻覺呈片斷形式，內容荒謬、離奇古怪。
3. 僵直型(catatonic type)：發病於青壯年，以精神運動障礙為突出的表現。常表現為緊張性興奮，突然暴發的行為異常：衝動、毀物、傷人、行動暴烈。此種興奮狀態可持續數日自行緩解，或轉入緊張型抑制狀態：表現違拗、木僵，嚴重者呈蠟

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	3/12

樣屈曲。不少病例可以缺乏緊張型興奮階段，一開始即出現木僵狀態。此型態常有自發性緩解，預後較好。

4. 單純型(simple type)：發病於青少年，以懶散、漫不經心、情感淡漠和意志缺乏為主要徵象。隨後病人對社會或集體生活日益缺乏興趣，可終日沉思、無所事事或無目的的外出遊蕩，一般無突出的幻覺、妄想症狀，隨著病程的進展精神衰退日益明顯。
5. 未定型(undifferentiated type)：符合思覺失調症的診斷標準，但不符合上述各型的診斷標準。

(四) 症狀

主要症狀可以分為兩大類：

1. 第一型(type I)正性症狀：妄想、幻覺、思考障礙及怪異行為。

妄想是指病人對外在的經驗或感受出現錯誤的解釋，且深信不疑，即使加以說明或有足夠證據，仍無法動搖其信念或想法，其中以關係妄想及被害妄想為最常出現；幻覺包括有視、聽、嗅、觸、味等感官性的幻覺，聽幻覺則是此類病人最常出現的困擾。聽幻覺評估的項目應包括：頻率、持續時間、負向內容數量及程度、聲音的大小和來源、影響日常生活困擾的程度與聽幻覺的自我控制情形。此外，常因對外界環境的判斷發生錯誤，出現脫離現實的情形，使個體在認知、情緒、社會功能呈現混亂，導致決策困難，病人常有感覺、推論思考、語言、情感表達以及注意力方面的障礙，導致決策困難。

2. 第二型(type II)負性症狀：情感表現平淡、社交退縮、不參與活動、思想貧乏、動作遲緩、自我照顧功能下降等。病程進入殘留期時，以負性症狀表現為主，病人對任何事物缺乏動機、無意志力，情感平板淡漠，言語內容貧瘠，並可能在工作、人際關係、自我照顧方面無法達到往日的水準而出現功能退化的現象，影響層面甚為廣泛。

(五) 常見檢查

1. 腦波儀(electroencephalography, EEG)。

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	4/12

2. 電腦斷層掃描(computerized tomographic scan, CT)。

3. 核磁共振影像(magnetic resonance imaging, MRI)。

(六) 常見治療

急性期的治療目標是緩解急性精神症狀，以藥物治療為主；慢性期的治療目標是在維持和改善功能，藥物仍須持續規則服用，合併精神復健、技能訓練與再教育為主；預防治療（持續和維持）以改善功能及預防精神症狀再復發為主。治療方法包括藥物治療、電氣痙攣療法、社會心理治療及精神復健等，以下說明。

1. 藥物治療：抗精神病藥物是治療思覺失調症最主要的藥物，早期第一代藥物如：Chlorpromazine、Haldol、Thioridazine，其作用機轉為阻斷多巴胺接受器，治療正性症狀效果佳，但對於負性症狀效果差。第二代藥物：除了阻斷多巴胺接受器，也會阻斷血清接受器，故對於正性症狀及負性症狀均能有效改善，如 Risperidone(Risperdal)、Clozapine、Invega、Zyprexa、Seroquel、Solian、Abilify。在臨床治療上，要注意藥物副作用，包括：錐體外徑症候群(extrapyramidal symptoms, EPS)、靜坐不能、心律不整、便秘、流口水、肢體僵硬、不自主抖動、眼睛上吊現象，若出現以上情形，須告知醫師並討論是否調整藥物劑量或停藥。
2. 電氣痙攣治療(electroconvulsive therapy, ECT)：若藥物治療效果差，或有嚴重攻擊他人、傷害自己的行為時，可考慮嘗試電氣痙攣療法。
3. 重複經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)：能改善思覺失調症患者的認知症狀。
4. 社會心理治療：強調思覺失調症病人心理及適應的困擾，並加強病人社交及處理事務的能力，幫助恢復日常生活及責任心。團體治療可聚焦於此時此刻的團體治療過程，鼓勵彼此分享，互相傾聽、瞭解、接納並獲得他人對自己的看法，也可以在團體中直接澄清彼此的感受，連結成員間的相似性，減少孤獨感，達到協助他人。使用的輔助治療有：心理治療、行為治療、環境治療、職能治療、婚姻治療、家庭治療、個人心理及團體治療等。
5. 精神復健治療：復健治療除了協助病人症狀轉移外，主要的重點在自我照顧能力

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	5/12

的訓練、獨立生活訓練、社交技巧訓練及職業技能技訓等，協助病人回歸社區，
復健社區包含：居家治療、社區復健中心、康復之家。

(七) 護理問題

1. 不遵行醫囑／知識缺失
2. 易對別人傷害或暴力／精神疾病的症狀
3. 易自我傷害或暴力／精神疾病的症狀
4. 知覺感受變異／正性症狀
5. 思考過程異常／妄想
6. 社交互動困難／思考過程的改變
7. 排便異常：便秘／藥物副作用
8. 自我照顧尋求協助：沐浴/衛生／知覺或認知障礙

(八) 護理措施

1. 不遵行醫囑／知識缺失
 - (1)探討病人的價值觀與治療建議不一致之處並檢視其特定衝突為何。
 - (2)與之共同探討改變或修正治療建議，使與之價值觀相容。
 - (3)說明哪些因素使他可能罹患某病或顯示已患有某病。
 - (4)解釋該病的徵象、症狀和危險因子，和病人討論目前與過去的經驗相比較。
 - (5)評估並記錄病人服藥的態度。
 - (6)給予藥物衛教，使其瞭解服用藥物可能引起之副作用，如有副作用出現予立即性處理，以增進其對服用藥物之順從性。
 - (7)指出病人服藥後改善之處，引導病人將病情改善與規則服藥作連結，以增進其病識感。
 - (8)解釋與治療建議有關的原則和程序並鼓勵病人與醫師討論自己的病情及藥物使用。
 - (9)一起討論治療的好處，強調這些治療對維持或重建其健康及安適有何助益。
2. 易對別人傷害或暴力／精神疾病的症狀

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	6/12

- (1) 評值目前的暴力危險因子，如：年輕、男性、暴力史、壓力、物質濫用史等。
- (2) 親視服藥並衛教規則服用藥物的重要性，視需要時給予依臨時醫囑藥物幫助控制行為。
- (3) 運用會談了解病人的需要及感受，教導質疑自己使用暴力行為之情況。
- (4) 引導思考其他的選擇或替代方案，以減少暴力之產生，如：深呼吸可放鬆並減輕焦慮；運動、散步或提供保護室給予大喊、搥打海綿牆，以發洩情緒。
- (5) 聯絡醫師評估約束或保護隔離的必要性，約束病人的身體以控制暴力行為，防止進一步的傷害；以冷靜、平穩的語氣向病人解釋我們做了什麼及為何要如此做；每 15 分鐘探視、監測藥物的副作用及病人的精神及情緒狀態，約束過程要提供充足的水分、營養及維持個人衛生。
- (6) 引導表達對此事件之感受，對其不合現實的認知及被害感受需立即澄清。
- (7) 提供心理治療措施，以協助增加對行為的控制，如：承擔自己行為的責任、獲得自我控制感及能表達正向感受等。

3. 易自我傷害或暴力／精神疾病症狀

- (1) 提供具治療性且安全的環境，不定時的安檢，移去所有危險物品並限制使用及借用，注意訪客是否帶有危險物品。
- (2) 將病人置於人多的房間或近護理站，必要時需隨時有人陪伴，可聯絡家屬來院協助或請看護 24 小時照顧。
- (3) 個別會談，傾聽感受與心聲，表達關心並鼓勵表達感受，了解欲自殺的原因方式及前兆，詳細記錄並做交班，讓其他成員知道。
- (4) 觀察與記錄病人言行及自傷行為的先兆。
- (5) 主動與病人討論其自殺的想法以了解內心的感受，不要給予個人的意見或批判，並給予發洩的機會(使用不傷害自己的方式來發洩情緒;例如提供保護室使用)。
- (6) 隨時評估病人的自殺意念強度、是否有自殺計畫等，並密切觀察之。
- (7) 觀察服藥狀況並執行檢查，以防藏藥及儲藥。
- (8) 與醫師討論病人情況及處理方式，請醫師以藥物協助或必要時約束保護。

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	7/12

(9)衛教以健康、不傷害自己的方式發洩或放鬆情緒（例如：打枕頭、扭毛巾、撕紙條、提供保護室……等）。

4. 知覺感受變異／正性症狀

(1)採接受性的態度鼓勵病人表達幻覺的不適感、內在的焦慮不安及害怕，並給予正向的回饋。

(2)同理和傾聽幻覺出現時的不適感。

(3)預防受幻覺影響而引起的自我傷害。

(4)安排活動來轉移對幻覺的注意，如：聽隨身聽、看電視、打球等。

(5)教導幻覺出現時的處理方式，如：聽音樂、收音機、看電視、與人談天等轉移注意力。

(6)提供陪伴病人與他人交換經驗的機會，並學習出現幻覺時的因應方式。

5. 思考過程異常／妄想

(1)觀察病人妄想內容，鼓勵引導出對妄想的解釋、感受和處理態度。

(2)不與之爭辯妄想內容，討論妄想的影響，過程中詢問個案呈現的事實，並以分散注意力的方式停止陷入妄想，談論真實的人與事，引導對其妄想存疑，澄清事實與妄想之間差異，協助現實判斷力。

(3)傳遞訊息時，口語表達應清晰明確、避免隨意碰觸病人及開玩笑。

(4)允許家屬的探視，安排固定的工作人員以建立信任的關係，以被動而友善的態度做觀察，多次而短暫的探視以降低個案的疑心。

(5)出現合乎現實想法時，適時給予正向加強。

(6)依醫囑給予抗精神病藥物，並確認病人確實服藥，以協助減輕妄想症狀。

6. 社交互動困難／思考過程的改變

(1)協助認識病房環境、同室病友及工作人員，以增加安全感。

(2)定時的陪伴和探視，以建立信任之治療性人際關係。

(3)評估限制病人社交互動的行為型態，協助確認導因。

(4)個案無法說話或不願說話時，可將觀察到的外在表現反映給個案，傳達對病人

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	8/12

的關心與興趣。

(5)鼓勵病人以非語言的方式表達自己，如：書寫、畫畫等非語言方式宣洩其感覺。

(6)先由一對一的互動開始，再將之帶入小團體、大團體的活動且不斷的重複學習。

(7)示範社交技巧，如眼睛注視對方、說話音量應適中、距離宜在一手臂長左右等。

(8)介紹其他病友與之認識並鼓勵互動，增加互動的頻率及社交技巧練習機會，並觀察其社交技巧的使用情形。

(9)尋找朋友陪伴及參與休閒活動，亦可增進正面情緒及紓解壓力。

7. 排便異常：便秘／藥物副作用

(1)超過3天未排便或有不舒服之主訴時，可依醫囑給予軟便藥或灌腸以協助解便。

(2)教導病人記錄 48 小時的所有攝取食物，與病人分析進食型態。

(3)教導並鼓勵病人減少油炸及刺激性食物之攝取，增加高纖維素食物，如：穀類食品、麵包、水果、蔬菜、果仁和種子等的攝取。

(4)要注意當增加食用高纖維食物的同時，也須增加水份或流質的攝取量，建議每天喝 2000-2500c.c 水以利軟化糞便，避免便秘加劇。

(5)養成良好之排便習慣，如：習慣餐後上廁所、每天定時上廁所（例如在早上固定時段）。

(6)鼓勵病人多參與活動，增加腹肌力量的運動，如：跑步、步行等，預防及治療便秘。

8. 自我照顧尋求協助：沐浴／衛生／知覺或認知障礙

(1)評估病人之衛生、修飾執行能力及過去之衛生習慣。

(2)視病人能力情況，與之討論並約定每幾天需完成洗頭、沐浴一次，盡可能自行執行完成衛生活動。

(3)當病人有能力獨立執行時，給予足夠的時間完成。

(4)將日常個人衛生用品簡化並放置固定位置，以方便取用。

(5)評估其執行能力，如需完全協助時：男病人請醫佐，女病人則由護理人員協助。

(6)需半協助時，於沐浴時間提醒病患，並與其一同準備用物，於浴室觀察其執行

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	9/12

情形，以增加病患接受度。

(7)完成沐浴時，帶病人至鏡前鼓勵注意外觀及儀容整理，必要時提供協助。

(8)每天晨間護理時，觀察口腔衛生執行狀況，視需要予引導或協助執行。

(9)以漸進式方式讓病人學習獨立完成沐浴，增加個案對自己的重視與興趣。

(10)對於病人衛生改變之進步，予具體指出並給予口頭的鼓勵與肯定。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王怡文、陳玉婷、賴佑銘(2021)·思考障礙之護理·於蕭淑貞(總校閱)，精神科護理概論-基本概念及臨床應用(十版，394-427頁)·台北市：華杏。
- (二) 台灣臨床TMS腦刺激學會(2024，4月14日)·rTMS腦刺激在思覺失調及精神疾病的運用。<https://www.tctmss.com.tw/l/rtms-schizo-psycho-treatment/>
- (三) 林政曄(2019)·思覺失調症穩定治療新趨勢—長效針劑和居家治療·彰基醫療健康防治季刊，(35)，18-19。
- (四) 陳惠君、余文雯、賴美玉(2022)·一位思覺失調症病人之護理經驗·高雄護理雜誌，(39)，94-105。
- (五) 蔡素玲、徐瑩嫻(2020)·思考障礙的護理·於蕭淑貞(總校閱)，精神科護理學(五版，268-293頁)·新北市：新文京開發。
- (六) American Psychological Association(2014)·DSM-5精神疾病診斷準則手冊·(台灣

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	10/12

精神醫學會譯)・台北市：合記書局。

七、附件

(略)

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	11/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.02.25	1.0	新制定	102 年 02 月 25 日護理部照護標準委員會通過；102 年 02 月 25 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	2.0	1. 主題名稱、目的及說明「精神分裂症」更名為「思覺失調症」。 2. 說明（一）定義（二）症狀（四）1.（8）常見藥物作內容修定。 3. 參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	2.1	1. 第三項說明內容部份刪修 2. 第六項參考文獻資料修正	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	2.2	1. 參考文獻新增於內文。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	2.3	1. 第三項說明第（一）目內容部份增刪。 2. 第六項參考資料增刪。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.04.11	2.4	1. 第三項第二、四、六目部份內容增刪。 2. 第六項參考資料文獻部份內容刪減及新增。	107 年 04 月 11 日護理長會議通過
107.09.12	2.5	1. 第三項第二、四、六目說明內容部份文字修訂。 2. 第六項參考資料文獻部份內容刪減及新增。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	2.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項說明第一目、第四目之 4 新增說明內容。 3. 第三項第六目之 1(9)新增文獻說明。 4. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 更新第六項參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	2.7	1. 第三項第一、二、四、六目部分內容及參考資料修訂。 2. 第六項參考資料部份增刪。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年

主題名稱	思覺失調症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L02	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
			08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	2.8	第三項第一目部分內容修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	2.9	1. 第三項第一、二、三、四、六目之說明內容修訂 2. 第三項第七、八目護理問題修正。 3. 第六項參考資料文獻部份增刪及更新。 4. 內文參考文獻統一刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.0	1. 第三項第七目之 4、第八目之 4.護理問題修正。 2. 第六項參考資料部份刪除。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.1	1. 第三項第八目之 3.(4)說明內容文字修訂。 2. 刪除第三項第九目。 3. 第六項參考資料部份刪除。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.2	1.新增第三項第六目之 3。 2.第六項參考資料部份更新。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。